Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 33ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810494

Processo nº **0073449-17.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): JOSE LUIZ MIRANDA CASANOVA

RÉU: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

SENTENÇA

Vistos, etc...

JOSE LUIZ MIRANDA CASANOVA**,** por intermédio de advogado regularmente habilitado, propôs a presente ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais em face da FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, todas qualificadas nos autos, na qual postula a antecipação dos efeitos da tutela com o objetivo de compelir a empresa ré a autorizar o fornecimento do medicamento Eritropoetina 40 mil UI semanal, essencial para o combate à Síndrome Mielodisplásica Proliferativa Sintomática, da qual é portador, e o pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura pelo plano de saúde. Pugnou pela concessão da gratuidade judiciária e juntou documentos.

Integro ao presente relatório trecho da Decisão que deferiu a Tutela de Urgência, onde constam as razões das partes:

> (...) Narra a inicial ser o autor portador de SÍNDROME MIELODISPLÁSICA PROLIFERATIVA SINTOMÁTICA, tendo que fazer o tratamento prescrito pela médica assistente, Eritropoetina 40 mil UI semanal, para conter a evolução da doença, necessitando da cobertura integral de seu tratamento, diante da gravidade de sua enfermidade.
>
> Requerido na esfera administrativa, a ré negou o fornecimento da medicação, conforme prova documento anexo aos autos.
>
> O autor solicitou que lhe fosse concedida a justiça gratuita. Sendo determinado que comprovasse a alegada hiposuficiência econômica, optou em pagar as custas, juntando o comprovante aos autos.
>
> No mesmo despacho, a requerida foi intimada para se manifestar acerca do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
>
> Intimada/citada, a empresa ré impugnou a gratuidade perseguida; da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de empresa de autogestão; que não foi apresentada nenhuma evidência de um pedido de urgência ou emergência; que a negativa do pedido ocorreu por ausência de cobertura legal e contratual, uma vez que não estava definido na Diretriz de Utilização definido pela ANS; que o medicamento não possui cobertura obrigatória pela operadora de saúde por ser considerada medicação off label; que a lista de procedimentos editados pela Agência não é meramente exemplificativa, concluindo que inexistiu qualquer ato ilícito praticado pela ré. Pugna pela realização de perícia, sendo ao final julgado improcedentes os pedidos. (...)”

À vista da contestação, no dia 16/09/2024 a parte autora foi intimada para réplica e ambas as partes para se manifestarem quanto ao interesse na produção de outras provas, justificando-as (ID 182273735).

Em 26/09/2024 a parte ré comparece aos autos apenas para comunicar a autorização do medicamento, cumprindo a decisão antecipatória de tutela. A parte autora deixou fluir o prazo sem manifestação.

Assim vieram-me os autos conclusos.

Relatados, no que importa, **DECIDO.**

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação dos Efeitos da Tutela c/c Indenização por Danos Morais visando a compelir a demandada a fornecer o medicamento prescrito pelo médico assistente, cumulado com pretensão indenizatória em razão da injustificada recusa.

Não havendo requerimentos específicos para produção de outras provas, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra.

O objeto deste feito restringe-se à análise da recusa da operadora de saúde a fornecer o medicamento prescrito à parte autora pelo médico assistente.

A negativa externada pela ré administrativamente não traz absolutamente nenhuma justificativa.

Incorporo a estas razões de decidir os fundamentos postos na decisão que concedeu a antecipação de tutela:

> [...] Consta dos documentos juntados aos autos pelo demandante o laudo detalhado e solicitação médica da terapia, certificando a urgência e a necessidade do tratamento.
>
> Assim, resta demonstrado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, máxime se o paciente corre risco de vida em decorrência da patologia diagnosticada e, ao levar em consideração a natureza da doença, o tratamento tardio ou com outro medicamento que não o adequado, tem-se que o quadro de saúde do requerente poderá se agravar .
>
> Incorporo os julgados à Decisão:
>
> > *APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.* ***ÓBICE DO PLANO DE SAÚDE EM DISPONIBILIZAR O MEDICAMENTO ERITROPOIETINA.*** *AUTORA DIAGNOSTICADA COM NEOPLÁSIA DE MEDULA ÓSSEA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. RECUSA DA RÉ EM CUSTEAR O REMÉDIO, SOB A ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, FORA DO ROL DO ANS. INADMISSIBILIDADE.* ***ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE CUSTEIO*** *DE MEDICAMENTO EXPRESSAMENTE PRESCRITO PELO MÉDICO CREDENCIADO DA PRÓPRIA RECORRENTE PARA TRATAMENTO DE DOENÇA SUJEITA À COBERTURA CONTRATUAL. SÚMULA 211 DO TJRJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00017819020228190031 202200172880, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/05/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2023) Grifei.*
>
> > *PROCESSO CIVIL – Interposição de recurso especial contra Acórdão da 8ª Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação da ré e* ***manteve a sentença que a condenou na obrigação de custear tratamento com uso do medicamento "Eritropoetina 40.000 U"*** *- Retorno dos autos ao relator para reexame da matéria recursal, por força do julgamento do Recurso Especial, que foi provido em parte pelo STJ - Verificação do preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura - Hipótese em que o autor é portador de Mielodisplasia Anemia refrataria com sideroblastos - Existência de indicação médica para o tratamento - Autor juntou documentos para comprovar que o medicamento prescrito está previsto no Rol da ANS e que apresenta as condições para o uso do medicamento, considerando o nível da hemoglobina inferior a 10g/dl, conforme Diretrizes de Utilização - De acordo com o entendimento do julgado do STJ, a operadora do plano de saúde pode ser excepcionalmente obrigada a cobrir o tratamento, caso preenchidos os requisitos para deferimento da cobertura - Ônus da prova era da ré, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC - Ré não requereu prova pericial, nem juntou documentos como recomendações de órgãos técnicos ou requereu diligências à Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar - Ré não se desincumbiu do ônus probatório - Conversão do julgamento em diligência - Inviabilidade - Demonstrado que o tratamento prescrito está previsto no Rol da ANS e sua cobertura pelo plano de saúde é obrigatória - Não é caso de reconsideração do acórdão - ACÓRDÃO MANTIDO. (TJ-SP - AC: 10691484620218260002 São Paulo, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 14/11/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023) Grifei.*
>
> > *DE NEOPLASIA MALIGNA/SARCOMA MIELOIDE (CLOROMA). NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO VIA ORAL DE USO DOMICILIAR VENETOCLAX (VENCLEXTA) EM ASSOCIAÇÃO DE HIPOMETILANTE. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PREVISTA NOS ART. 10, VI E ALÍNEAS 'C' DO INCISO I E 'G' DO INCISO II DO ART. 12 DA LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME PRESCRITO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - O fornecimento de medicamentos para tratamentos antineoplásicos se encontra previsto na Lei nº 9.656/98. O inciso VI do Art. 10, ressalva o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do Art. 12, no que se refere a fármacos antineoplásicos para uso domiciliar, o que também é respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende como ilícita a negativa de custeio de medicamento antineoplástico de uso domiciliar, não se havendo falar em rol de cobertura no que se refere aos medicamentos para tratamento de câncer, que devem ser fornecidos, pela operadora de plano de saúde, conforme prescrição do médico assistente. 2 - De acordo com a alínea b do inciso I do Art. 12 da Lei nº 9.656/98, há previsão de cobertura obrigatória para serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, afigurando-se abusiva a demora na autorização de exames requisitados para o tratamento do paciente, mormente em casos graves como o da espécie em tela, relativo a idoso portador de câncer. 3 - O fato de que eventual procedimento não conste do rol da ANS não significa, por si só, que a sua prestação não possa ser exigida, consistindo a referida listagem no mínimo a ser garantido aos segurados, mas não se revestindo de cunho taxativo, ainda mais*

quando outro tipo de tratamento não é adequado, tampouco possível, como ocorrido no caso. 4 - Configurada a atitude abusiva e contrária aos deveres de cooperação e boa-fé que devem reger as relações contratuais e os prejuízos à saúde física e mental do paciente, impõe-se o dever de reparação. O dano moral é in re ipsa. Presume-se da mera conduta desabonadora do agente e dos seus efeitos na esfera psíquica do lesado, pessoa gravemente enferma e já fragilizada emocionalmente pela própria severidade da doença, que ainda se depara com obstáculos causados pela operadora para a autorização da cobertura contratual de tratamento imprescindível, em momento de aflição extrema de risco de vida, à vista do óbito ocorrido poucos meses após iniciá-lo. 5 – Recurso provido para a reforma da sentença, no sentido de reconhecer a ilicitude da negativa do fornecimento da medicação Venetoclax (Venclexta) e da demora da autorização do exame de estudo medular completo prescrito em caráter de urgência, bem como para condenar a operadora recorrida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000940-30.2020.8.17.2001, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, na conformidade do voto do Relator e do termo de julgamento que integram o presente aresto. Recife, data registrada no sistema. Alberto Nogueira Virgínio Desembargador Relator 04(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000940-30.2020.8.17.2001, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Gabinete do Des. Alberto Nogueira Virgínio)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. MEDICAÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA. PACIENTE COM HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA - HPN E SÍNDROME MIELODISPLÁSICA ASSOCIADA. RESOLUÇÃO ANS N. 428/2017. ROL EXEMPLIFICATIVO. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Às operadoras de plano de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também os meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 3. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura o fornecimento de medicamento recomendado por especialista, visando ao controle da doença e melhora dos sintomas da enferma, proporcionando-lhe maiores sobrevida global e taxa de controle da moléstia que lhe acomete. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde da RN n. 428/2017 da ANS é exemplificativo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio/fornecimento de medicamento, conforme prescrição médica idônea. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-DF 07380871420208070001 DF 0738087-14.2020.8.07.0001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.

Destaco que o Requerente conta com quase 69 anos de idade, a quem a lei confere prioridade absoluta no atendimento, **conforme Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o qual em seu art. 2º assim prevê :**

> *"Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção (http://www.jusbrasil.com.br/diarios/43335042/djpe-20-11-2012-pg-173#%23) integral de eu trata a lei, **assegurando-se-lhe , por lei ou outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade**."*

Os Tribunais pátrios firmaram entendimento majoritário no sentido de que o rol da ANS tinha caráter meramente exemplificativo, constituindo referência das coberturas mínimas obrigatórias, mas não excluindo outras que se fizessem necessárias, por expressa indicação médica, para o tratamento de doença coberta contratualmente. Ou seja, se a doença é coberta contratualmente, o seu tratamento - de acordo com a indicação médica - também deve ser.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela taxatividade do rol da ANS, contudo, com algumas ressalvas, especialmente quando demonstrada evolução da doença mesmo com outros tratamentos / exames realizados.

Para por fim às oscilações jurisprudenciais foi sancionada a Lei nº 14454/2022 que estabelece critérios que determinam a cobertura de exames ou tratamentos não incluídos no rol de procedimentos do sistema de saúde suplementar, desde que comprovada a sua eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, o que é o caso dos presentes autos.

Nessa ordem de ideias, a despeito do esforço argumentativo da parte ré, afigura-se desarrazoada a recusa de custeio efetuada pela seguradora com base, exclusivamente, no rol de procedimentos da ANS.

Além disso, o medicamento prescrito tem registro na ANVISA, o que demonstra que a contestação apresentada pela ré é destituída de qualquer fundamento.

Ademais, o objeto da restrição não pode ser algo que desnature a própria função do contrato, qual seja, prestar serviços relacionados à saúde.
Nesse sentido já se pronunciou o TJPE quanto ao fornecimento dessa medicação especificamente, em recentíssima decisão:

> EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MIELODISPLÁSICA DENOMINADA DE ANEMIA REFRATÁRIA NÃO SIDEROBLÁSTICA (CID D46.4). **INDICAÇÃO DE USO DA**

> **MEDICAÇÃO EPREX 40.000UI.** NEGATIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER O MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA PELO PLANO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CABIMENTO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso contra sentença que reconheceu a obrigação da operadora de plano de saúde de fornecer medicamento prescrito para tratamento de neoplasia mielodisplásica, patologia coberta pelo contrato. A parte autora, beneficiária do plano, demonstrou a necessidade da medicação EPREX 40.000 UI para tratar a anemia refratária de que é portadora. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se a negativa da cobertura pela operadora de plano de saúde, sob o argumento de que o medicamento é de uso experimental ou fora da bula, é lícita, considerando a prescrição médica e a cobertura contratual. III. Razões de decidir 3. A negativa de cobertura foi considerada abusiva, uma vez que o medicamento está registrado na ANVISA e o tratamento prescrito pelo médico assistente é necessário para a preservação da vida da paciente. 4. Além disso, comprovou-se nos autos que o medicamento requerido é indicado aos pacientes portadores da doença que acomete a Autora. 5. O plano de saúde não pode limitar o tipo de tratamento necessário para doenças cobertas pelo contrato, conforme entendimento pacificado pelo STJ. 6.A negativa de cobertura, baseada na alegação de uso experimental do fármaco, se mostra abusiva, especialmente considerando o entendimento consolidado pelo STJ, que veda a recusa de cobertura para medicamentos registrados na ANVISA, ainda que utilizados fora da bula (off-label). 7. Segundo entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação desprovida. Tese de julgamento**: "É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, quando o fármaco encontra-se registrado na ANVISA e sua aplicação é necessária à preservação da vida e saúde do paciente."** Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, IV e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.005.551/SP;STJ, AgInt no REsp nº 2.016.007/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.04.2023;TJPE, Agravo de Instrumento n. 0009902-89.2023.8.17.9000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0106940-49.2023.8.17.2001, em que figuram como Apelante Bradesco Saúde S/A e como Apelada Aldair Rio Lima de Melo; Recorrido: Bradesco Saúde S.A.: ACORDAM os Desembargadores que integram a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo conforme o relatório e os votos que passam a integrar este aresto. Recife, data da certificação digital. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Desembargador Relator 7 (TJ-PE - Apelação Cível: 01069404920238172001, Relator: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC))

Dessa forma, conforme acima demonstrado, constata-se a prática de ato ilícito pela Operadora de Plano de Saúde em negar o medicamento prescrito, impondo a procedência do pedido.

A operadora foi contratada para prestar um serviço e a recusa injustificada constitui ato ilícito e prática abusiva.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, em hipóteses com a presente a existência do dano subsiste independente de comprovação, pois os próprios fatos já constituem ofensa à dignidade da pessoa, evidenciando um prejuízo moral, que se convencionou chamar dano moral *"in re ipsa"*.

Nesse sentido é uníssono o Tribunal de Justiça de Pernambuco, consoante se vê pela Súmula nº 35:

> **Súmula 35/TJPE:** "A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral". 2. A recusa de cobertura de procedimento médico é capaz de causar ao indivíduo significativo abalo psíquico, sendo, no caso, presumido (dano moral in re ipsa) desde que seja grave o estado de saúde, e haja necessidade de tratamento urgente. 3. Fixação do valor do dano moral deve seguir os ditames da razoabilidade e proporcionalidade.

Certo o dever de indenizar, fixo o montante devido.

Muito embora a lei não estabeleça os parâmetros para que seja fixada a indenização a título de danos morais, impõe-se ao magistrado observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a arbitrá-los sem que seja irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, e, ao mesmo tempo, não seja excessivo a ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa. Além de reparar o dano (ou minimizar os seus efeitos), deve também atender aos critérios pedagógico e sancionatório, levando-se em consideração a gravidade do fato em si, a extensão do dano sofrido e o desgaste emocional impingido à parte demandante.

No presente caso o autor é pessoa idosa e acometido de uma doença grave, um tipo de câncer hematológico. É notório - e por isso independe de prova específica - que qualquer pessoa acometida de uma doença tão grave precisa de estabilidade emocional para enfrentá-la. Nesse contexto, o estresse suportado em decorrência da incerteza quanto à possibilidade de realizar o tratamento contribui significativamente para a piora do quadro clínico de uma maneira geral. Não precisa ser médico perito para se chegar a essa conclusão, lastreada nas regras comuns de experiência.

Nesse sentido:

> Apelação cível. Plano de saúde. Indenização por danos morais. Negativa de cobertura para fornecimento de medicamento para tratamento de câncer. Dano moral. Sentença de improcedência. 1.Autor falecido no curso da ação. Indenização por dano moral. Transmissibilidade aos herdeiros. Cabimento. Violação moral atinge direito subjetivo; porém o direito à respectiva indenização tem natureza patrimonial; portanto, é transmissível aos herdeiros. Precedentes STJ. 2.Caracterização de dano moral. Ilícito que consistiu na indevida recusa. Abusividade da negativa já reconhecida em outro processo. Negativa agravou a situação de aflição psicológica e de angústia. Doença grave. As pessoas contratam planos de saúde, visando enfrentar situações de urgência e emergência com um pouco mais de tranquilidade. A conduta da ré exarcebou sofrimento em momento tão delicado. Assim sendo, está devidamente caracterizado o dano moral. Sopesadas as circunstâncias, razoável fixar a indenização em R$10.000,00. Precedentes da Câmara. Apelação provida.(TJ-SP - AC: 10284797920208260100 SP 1028479-79.2020.8.26.0100, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 15/03/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2021).

Por essas razões, fixo a indenização dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, **confirmo os termos da Decisão antecipatória de tutela** ao passo em que JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais e CONDENO A RÉ:

1) a custear integralmente o tratamento prescrito pelo médico assistente fornecendo a medicação prescrita, devendo a parte autora renovar a prescrição médica a cada três meses.

2) ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais),** acrescidos de correção monetária com base na tabela do ENCOGE e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN), ambos contados a partir desta data.

3) ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando o valor da causa atribuído ao procedimento somado aos danos morais deferidos (com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, certifique-se o pagamento integral das custas processuais e arquivem-se os autos.

Não sendo realizado o pagamento das custas, intime-se a parte sucumbente para fazê-lo, no prazo de quinze dias, **sob as penalidades da lei.**

Em não havendo manifestação, à Diretoria Cível para efetuar os cálculos dos valores anteriormente mencionados e, em seguida, oficie-se à Procuradoria do Estado, para as devidas providências legais, e à Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco e ao Comitê Gestor de Arrecadação, nos termos dos Provimentos nº 007/2019 - CM, de 10 de outubro de 2019, e nº 003/2022-CM, de 10 de março de 2022.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte adversa para contrarrazões e encaminhem-se os autos ao E. TJPE, observadas as formalidades legais, independentemente de novo despacho.
Recife, 13 de outubro de 2024.

ANA CAROLINA AVELLAR DINIZ
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: ANA CAROLINA AVELLAR DINIZ
13/10/2024 10:04:15
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 185118544

24101310041521600000180561580

IMPRIMIR GERAR PDF